MAPO ANALYZER- Salas de hospitalización/residencias

1. Alcance y preparación

Estas instrucciones explican cómo cumplimentar el programa, no sustituyen la metodología MAPO ni la valoración técnica del estudio. Se centran en la evaluación de salas de hospitalización y residencias

- Prepare el inventario de camas, pacientes y equipos, los cuadrantes reales, las frecuencias de movilización y el plano o visita a los espacios.
- Documente el periodo y las fuentes de los datos (observación, personal, registros y entrevistas).
- No introduzca cifras estimadas sin identificar su origen y limitaciones.

2. Acceso e identificación de unidades

Desde la bienvenida pulse «Acceder al programa», seleccione «Salas de hospitalización» e indique cuántas salas, plantas o secciones se evaluarán (de 1 a 50). Identifique cada unidad con un nombre inequívoco. Son unidades de evaluación independientes; no deben confundirse con los «tipos» de baños o habitaciones que se crean dentro de una unidad.

Separe unidades cuando difieran sustancialmente la exposición, dotación, organización, pacientes, equipamiento o espacio. Complete cada una antes de revisar los resultados individuales o conjuntos. Si un trabajador atiende varias unidades, evite duplicar su exposición en el registro.

3. Clasificación funcional de pacientes

Clasifique por capacidad efectiva de colaborar en las movilizaciones consideradas, no por edad, diagnóstico o grado administrativo de dependencia.

Categoría en pantalla	Criterio de registro
Autónomo	Realiza las movilizaciones pertinentes sin ayuda del personal.
Colaborador	Necesita ayuda, pero colabora activamente cuando se le solicita. Se contabiliza como PC.
No colaborador	No colabora activamente en la movilización. Registre aquí a los no colaboradores que no se hayan introducido como encamados.
Encamado	Paciente que permanece encamado según la situación registrada. Introducir solo en «Encamado»: el programa lo suma automáticamente a NC.

Cálculos automáticos de esta pantalla: NC = No colaborador + Encamado; PC = Colaborador; NA = NC + PC. Los pacientes autónomos no forman parte de NA. Ejemplo: 5 autónomos, 4 colaboradores, 3 no colaboradores y 2 encamados: NC = 5; PC = 4; NA = 9; total de pacientes = 14.

IMPORTANTE: nunca duplique los encamados en el campo «No colaborador». En casos de colaboración variable, utilice un criterio temporal coherente con la actividad real y documente la decisión.

4. Personas trabajadoras y turnos

En el módulo de personas trabajadoras que realizan MMP introduzca los profesionales efectivamente expuestos y sus horarios reales. Verifique turnos, solapes y dotaciones. No equipare plantilla total, personas presentes y personas que realizan movilizaciones. El denominador OP afecta directamente al índice; compruebe su consistencia en cada unidad.

5. Tareas y movilizaciones

Consigne los movimientos pertinentes por turno distinguiendo levantamientos totales o parciales y actuaciones con ayuda técnica o sin ella. El uso real del equipo, no su mera disponibilidad, determina la clasificación de una movilización «con ayuda». Contraste frecuencias con observación y personal, y evite contabilizar dos veces una misma operación.

Compruebe especialmente el número y proporción de operaciones con ayuda antes de revisar FS, FA o utilizar «Simular mejoras». La simulación no modifica el estudio original.

6. Equipos de ayuda y sillas de ruedas

Registre los equipos que se encuentran realmente disponibles y utilizables; compruebe suficiencia y adecuación conforme a las preguntas del programa. Diferencie elevadores, camillas y camas regulables (FS), ayudas menores (FA) y sillas de ruedas (FC). Agrupe sillas únicamente cuando compartan las características evaluadas y registre la cantidad de cada tipo. Los datos descriptivos no siempre modifican la puntuación; consulte las ayudas «?» del propio formulario.

7. Baños y habitaciones: creación de grupos o tipos

En estos módulos no se introduce cada estancia por separado cuando existe una configuración repetida. Cree un «Tipo» por cada combinación de condiciones puntuables idéntica y escriba «Número de unidades» correspondiente. Si cambia cualquier característica evaluada, cree otro tipo; máximo 50 tipos por registro.

7.1. Baños para higiene (PMB)

Agrupe espacios destinados a la higiene asistida solo si son iguales en las condiciones puntuables: espacio para utilizar ayudas, puerta de anchura inferior a 85 cm y obstáculos fijos. La apertura de puerta y los elementos como ducha/bañera pueden recogerse además como datos descriptivos.

7.2. Baños con WC (PMWC)

Agrupe aseos con inodoro según igualdad en: espacio para silla de ruedas, altura del WC, barra lateral, puerta de anchura inferior a 85 cm y espacio lateral WC-pared inferior a 80 cm. La apertura hacia dentro figura como dato descriptivo. Los baños de higiene y los baños con WC se registran en pantallas diferentes. Si una estancia cumple ambas funciones, describa su presencia en cada categoría cuando proceda, sin duplicarla dentro de la misma categoría.

7.3. Habitaciones (PMH)

Cree tipos según las condiciones puntuables mostradas: espacio entre camas, espacio a los pies, secciones/articulación de la cama, espacio libre bajo ella y característica de altura/asiento contemplada por el formulario. Registre observaciones y dimensiones adicionales cuando se soliciten, diferenciando datos puntuables y descriptivos.

EJEMPLO: hay 12 habitaciones: 8 comparten todas las condiciones evaluadas y 4 tienen un espacio lateral insuficiente. Registre Tipo 1 = 8 unidades y Tipo 2 = 4 unidades, cada uno con sus

respuestas. No registre 12 tipos innecesarios ni un único tipo de 12 si existe una diferencia puntuable.

Compruebe que la suma de unidades de los tipos coincide con el inventario físico. PMB, PMWC y PMH se obtienen mediante puntuaciones ponderadas por el número de unidades; PMamb y Famb se calculan a partir de los tres componentes. El cálculo en baños puede ser parcial mientras no exista PMH.

8. Formación (FF)

Introduzca cobertura, contenido, duración, carácter teórico-práctico, antigüedad y, cuando sea aplicable, comprobación de eficacia. Conserve evidencias de programas, asistencia y fechas. Algunos campos son descriptivos y otros intervienen en FF; utilice las preguntas y aclaraciones del programa.

9. Resultados, simulación y documentos

- Revise el resultado MAPO, clasificación y desglose de factores para cada unidad, verificando que coinciden con los datos de campo.
- En estudios de varias unidades, examine los resultados individuales antes de interpretar el global; una media no debe ocultar condiciones desfavorables.
- Guarde el proyecto JSON para conservar y reabrir datos. Genere el informe Word y revise todas las cifras, tablas, observaciones y limitaciones antes de emitirlo.
- Al simular mejoras, modifique solo condiciones técnicamente viables; el resultado simulado es hipotético y no altera el estudio original.

10. Comprobaciones antes de cerrar

- La cantidad total de pacientes coincide con los registros de la unidad.
- Ningún paciente encamado se ha contado también como no colaborador.
- OP, horarios, dotación y movilizaciones corresponden a la misma unidad y periodo.
- Las cantidades de sillas, baños y habitaciones de todos los tipos suman el inventario real.
- Los tipos agrupados son homogéneos en todas las características puntuables.
- Las ayudas están disponibles y se han diferenciado del uso efectivo.
- Los resultados y los documentos exportados se han revisado manualmente.